

尿道中段吊带（用于压力性尿失禁）

WARWIKI

患者须知 · 治疗压力性漏尿的一种快速、有效的手术

尿道中段吊带是治疗女性压力性尿失禁最常见的手术——即咳嗽、大笑、提重物或运动时出现漏尿。手术将一条细软的补片吊带置于尿道中段下方，为其提供支撑，使腹压升高时尿道保持关闭。手术快捷，通常为门诊手术，疗效显著且持久。

关于这项手术

通过阴道内的一个小切口，将一条细吊带**无张力**地放置于尿道中段下方，像吊床一样托住尿道。当您咳嗽或用力时，尿道压向吊带并保持关闭。术后**无需任何操作**，吊带自动发挥作用。手术入路分为经耻骨后和经闭孔两种，也有单切口"迷你"吊带；您的医生会为您选择最适合的方式。

关于补片

合成尿道中段吊带是女性健康领域**研究最为充分**的手术之一，长期安全性和有效性均有可靠依据。它与曾受到FDA警告的用于盆腔器官脱垂（POP）的经阴道网片**不同**。如果您希望避免使用合成补片，也可选择以**自体组织**制成的筋膜吊带作为替代方案。

名词解释

压力性尿失禁

腹压升高时漏尿，如咳嗽、大笑、提重物。

尿道中段吊带

支撑尿道中段的补片吊带。

无张力

吊带托于尿道下方，不压迫尿道。

经耻骨后／经闭孔

吊带可走行的两条路径，效果相当。

自体组织吊带

用您自身组织而非补片制成的吊带。

补片暴露

少见并发症，部分补片出现在阴道内；可处理。

会疼吗？ 手术在麻醉（全身麻醉或椎管内麻醉）下进行，术中无感觉，通常不到30分钟。大多数患者**当天回家**，仅有轻微酸痛，很快即可恢复轻度活动。

如何准备

- 遵照**麻醉须知**（禁食、按医嘱停用抗凝药）。
- 术前做**尿液检查**排除感染；有时需进行膀胱功能检测。
- 安排人接送；计划术后数周内从事轻体力活动。

过程

- 1 您处于睡眠或麻醉状态；术中使用抗生素预防感染。
- 2 在阴道内做一小切口，将吊带无张力地置于尿道中段下方。
- 3 耻骨上方或腹股沟的小出口自然愈合；阴道切口缝合关闭。
- 4 通常需在回家前自行排尿，确认膀胱可正常排空。

之后

- 轻微酸痛和少量出血属正常现象。
- **约6周内避免重体力劳动、用力及性生活。**
- 若初期排尿缓慢，偶尔需短期留置导尿管。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **无法排尿**或感觉膀胱排不空
- 发热或大量出血
- 疼痛加重，或日后出现性交痛、阴道异常分泌物（可能为补片相关问题）

需要记住的三件事

1. 尿道中段吊带通过支撑尿道来控制压力性漏尿——手术快捷、门诊完成、效果显著，术后无需任何操作。
2. 其补片经过充分研究，与已被召回的脱垂网片不同；如您希望，也可选择自体组织吊带。
3. 约6周内避免重体力劳动及性生活。如无法排尿、出现发热或日后出现疼痛／分泌物，请及时就医。